四、综合治疗（手术、放疗、化疗等）

1.小细胞癌→首选**化疗**（依托泊苷+铂类）

2.I、II期等 NSCLC→首选手术。若不能手术（T_4、N_3、M_1 等）→只能放化疗 姑息性治疗

注意：放疗可使肿块缩小，因此能缓解呼吸困难、疼痛等临床表现；但放疗会抑制骨髓造血，因此可致外周全血细胞减少

3.靶向治疗成功关键是选择特异性靶标：

①以 **EGFR/HER1/ERBB1 突变为靶点：厄洛替尼、吉非替尼**（E-厄、吉他-HE）

②以 ALK 或 ROS1 重排为靶点：克唑替尼（K-克）

③以肿瘤血管生成为靶点：贝伐珠单抗（学阀）

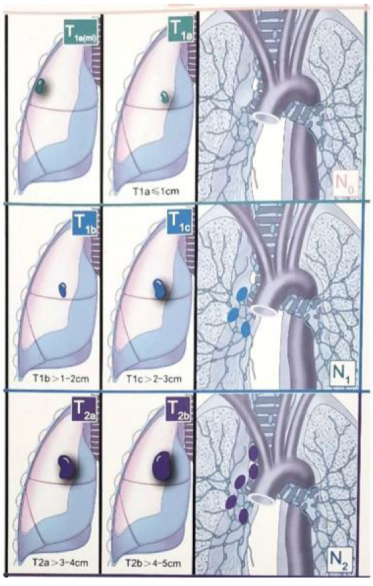
④以 PD-L1 为靶点：派姆单抗（P-pai-派）

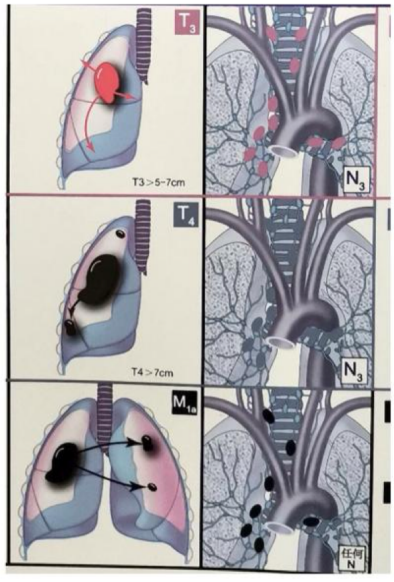
专题串联·肺癌 TNM 分期（内科+外科）

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

大小、浸润深度、浸润范围

T_1	≤3cm
T_2	＞3、≤5cm
T_3	＞5、≤7cm
T_4	＞7cm（生我气就抽烟）VS COPD 358　评估严重程度:1级轻度≥80%,2级中度50-79%、3级重度30-49%、4级极重度<30%
N_0	无区域淋巴结转移
N_1	同侧支气管周围、肺门、肺内淋巴结转移 局限在肺内
N_2	同侧纵隔、隆突下淋巴结转移 我要到对面去,此时在中间区域
N_3	对侧肺门、纵隔淋巴结转移，或前斜角肌及锁骨上淋巴结转移 对侧、远处
M_0	无远处转移
远处转移 M_1（IV期）	**对侧肺叶出现癌结节；恶性胸腔/心包积液或胸膜/心包结节；远处器官转移灶**　VS对侧出现淋巴结转移是N3　恶性胸腔积液/心包积液:在胸腔积液/心包积液发现了癌细胞





VS 肿瘤局部扩展引起的胸腔积液:不是恶性胸腔积液,只是反应性渗出或者由于癌细胞堵住了毛细血管、静脉导致回流不畅→积液